TBG:血浆中运输甲状腺激素的蛋白质
不是甲状腺球蛋白TG(甲状腺激素的原料)

（六）妊娠期甲亢

（1）妊娠→甲状腺结合球蛋白 TBG↑→TT_3、TT_4↑（总 TT_4=游离 FT_4+与 TBG 结合的 T_4），所以妊娠期诊断甲亢

不用 TT_3、TT_4 用游离FT3游离FT4

《诊断学》：

TBG↑：妊娠、雌激素（某些避孕药）、急性病毒性肝炎等

TBG↓：雄激素、糖皮质激素、低蛋白血症（如肾病综合征）等
分解蛋白质

（2）妊娠期手术时机：妊娠中期（4-6 月）有手术适应症、且无手术禁忌症时（早晚要出事）

真题解析 • Graves 病

习惯-读完所有选项；意识-选择最佳答案；巩固-复习核心考点

1. 2013N108-110 A 女性，35 岁，乏力，心悸一年余，近 2 个月症状加重，伴厌食、消瘦、手颤。查体：甲状腺弥漫性肿大，心率 126 次/分，心律整。实验室检查示 FT_3、FT_4 显著增高，TSH 降低。

108.该患者最可能的诊断是

A.Graves 病

B.自身免疫性甲状腺炎 桥本(甲减)

C.多结节性病毒性甲状腺肿 结甲

D.亚急性甲状腺炎 外科考

109.为进一步确诊，以下检查项目中意义重大的是

A.促甲状腺激素受体抗体 TRAb,尤其是TSAb,Graves病的一线诊断指标

B.^{131}I 摄取率

C.甲状腺 B 超

D.甲状腺核素显像

110.对该患者治疗，应首选的方法是

A.咪唑类药物

B.手术治疗

C. ^{131}I 治疗

D.碘制剂

感性认识:浸润性突眼是一种自身免疫,是炎症反应,选红肿热痛

2. 2016N174 X Graves 眼病活动期的指标有 1238

A.眼球活动性疼痛

B.突眼度 增加≥2mm

C.复视

D.结膜充血

指标	视力下降≥1 行
	突眼度增加≥2mm，眼睑充血、结膜充血，自发性球后疼痛、眼球运动时疼痛 2个“血”2个“痛”
	眼睑肿胀、球结膜肿胀（复视）、泪阜肿胀 球结膜肿胀无需看近物就会有复视 3个“肿”
	任一方向眼球运动减少≥8 度
治疗	可给糖皮质激素（糖皮质激素可致低钾）保钠排水排钾

3. 2017N88-90 A 女性，25 岁，低热，乏力，心悸 2 周余。检查甲状腺弥漫肿大I度，无触痛，心率 110 次/分。血液检查 FT_3、FT_4 明显升高，TSH 明显降低。

88.该患者最可能的诊断是 甲亢

A.Graves 病

B.亚急性甲状腺炎

答案:1-3 AAA ACD ABA

C.结节性甲状腺肿
D.自身免疫性甲状腺炎
89.该患者最恰当的治疗是
A.^{131}I 治疗
B.甲巯咪唑
C.糖皮质激素治疗
D.口服非甾体类抗炎药

药物无效→手术/^{131}I

90.患者经治疗后，甲状腺激素水平仍较高，症状不缓解，下一步最恰当的处理是
A.^{131}I 治疗
B.改服碘剂治疗 用于甲危/原发性甲亢的术前准备
C.糖皮质激素加量
D.加服 β 受体拮抗剂 辅助措施

4. 2018N55 A 以下关于甲状腺毒症周期性瘫痪的临床表现中，正确的是
A.以亚洲青年女性多见 男性多见
B.与甲亢疾病严重程度相平行 BMR
C.高碳水化合物饮食可诱发 胰岛素↑→K^+入胞
D.为不对称性肢体软瘫

一般:甲状腺疾病女性多见,胆囊疾病也是为女性多见(雌激素抑制胆囊收缩)
特殊:周期性瘫痪男性多见,非结石性胆囊炎为男性多见

5. 2020N76-78 A 女性，60 岁。1 个月来无诱因感心悸，呈发作性，持续 1-2 小时可自行缓解，半小时前再次发作来院。近半年来自觉消瘦、乏力、出汗，食欲好，睡眠差，血压升高。查体：T 37.2℃，P 90 次/分，BP 140/70mmHg，皮肤出汗，颈部未闻及血管杂音，双肺正常，心界不大，心律不整，手颤(±)。心电图显示：心室率 136 次/分，P 波消失，可见形态不等的 f 波，QRS 波时限 0.08s，间距不等。

房颤

若题目为:年龄更大,甲状腺无肿大→淡漠型甲亢(常伴有房颤、易发生甲危,明显消瘦)

76.该患者最可能的诊断是
A.阵发性室上性心动过速
B.频发性房性期前收缩
C.阵发性心房颤动 无窦性心律(无P波)
D.阵发性心房扑动
77.该患者最可能的原发病因是
A.高血压
B.糖尿病
C.冠心病
D.甲状腺功能亢进症
78.该患者正确的治疗措施是
A.选用洋地黄类药物减慢心室率
B.行射频消融术转复心律
C.治疗原发病
D.临床观察

6. 2021N88-90 A 女性，30 岁。多食、易饥、多汗伴大便次数增多 3 个月，体重下降 7kg。查体：皮肤湿润，弥漫性甲状腺II度肿大。心率 120 次/分，律不齐，早搏 3-4 次/分。实验室检查：TgAb(-)，TPOAb(-)，TRAb(+)，肝功能和血常规均正常。

答案:4-6 C CDC ABB

88.该患者最可能的诊断是
A.Graves 病
B.亚急性甲状腺炎
C.桥本甲状腺炎
D.结节性毒性甲状腺肿
89.对确诊最有价值的检查指标
A.TgAb(-)
B.TRAb(+) TSAb(+)
C.TPOAb(-)
D.TSBAb(+) TBAb,block阻断
90.如果患者希望在一年内妊娠生育，正确的治疗方案是
A.首选 ^{131}I 治疗　　首选甲巯咪唑/他巴唑MMI,但妊娠早期(1-3月)首选丙硫氧嘧啶PTU(pregnant three)
B.首选丙硫氧嘧啶治疗
C.对症治疗，选用美托洛尔
D.首选左甲状腺素

7. 2022N88-90 A 女，25 岁。易饥、多食、心悸、多汗伴大便次数增多 3 个月，体重下降 7kg。查体：皮肤湿润，甲状腺 II 度肿大。心率 120 次/分，心律不整，早搏 3-4 次/分，双手震颤(+)。实验室检查：血 FT_3、FT_4 升高，TSH 降低，肝功能和血常规均正常。
88.对该患者确诊最有价值的检查结果是
A.TPOAb 阳性
B.TgAb 阳性
C.TPOAb 和 TgAb 均阳性
D.TRAb 阳性
89.给予患者甲巯咪唑 10mg，每日 2 次治疗。2 周后门诊复查：近三天来感咽痛，体温 38.2℃，咽部稍充血，肝功正常，外周血 WBC 2.1×10^9/L，中性粒细胞 0.8×10^9/L，考虑粒细胞减少的最可能原因是
A.疾病本身所致粒细胞减少
B.急性病毒感染
C.甲巯咪唑引起的粒细胞减少
D.假性粒细胞减少
90.针对患者粒细胞减少，不适合的处理是
A.换用丙硫氧嘧啶 100mg，每日三次 停药
B.停用甲巯咪唑
C.给予升白细胞药物
D.严密监测粒细胞变化

8. 2024N159 X 女性，31 岁。3 年前患 Graves 病，服用抗甲状腺药 2 年后停药，1 个月来出现心悸、多汗、手颤、消瘦，甲功检查显示 FT_3 和 FT_4 明显升高，TSH 显著降低，TRAb(+)，肝功能和血常规结果正常。目前正值哺乳期。查体：甲状腺III度肿大，突眼度为 21mm。对该患者治疗方法不恰当的有
停药复发　Graves病　非妊娠
A.推荐选用 MMI 治疗 是恰当的
B.^{131}I 治疗
C.急诊甲状腺切除术 甲亢手术不能急诊手术,都是择期手术
急诊手术:"要死了"

答案:7-8 DCA BCD

D.碘剂治疗用于甲危/原发性甲亢的术前准备

9. 2025N88-90 A 女性，35 岁。多食、易饥、多汗伴腹泻 1 个月，体重下降 3kg。查体：皮肤湿润，甲状腺 II 度肿大，质软。心率 120 次/分，心律齐，双手震颤(+)。实验室检查：血清 FT_3、FT_4 显著升高，TSH 降低，TgAb(-)，TPOAb(-)，尿糖可疑阳性，肝功能和血常规均正常。

88.目前该患者最可能的诊断是

A.桥本甲状腺毒症

B.Graves 病

C.亚急性甲状腺炎

D.多结节性毒性甲状腺肿

89.为明确诊断，最有价值的检查是

A.甲状腺 B 超

B.TRAb

C.OGTT

D.HbA1C

90.对该患者的治疗选择，不适当的是

A.对症治疗，如口服普萘洛尔

B.如无妊娠计划，可选 ^{131}I 治疗

C.如有妊娠计划，首选甲巯咪唑治疗 有妊娠计划就当成pregnant three,妊娠早期(1-3月)首选丙硫氧嘧啶PTU

D.ATD 治疗无效可外科手术治疗

思维导图 • Graves 病

思维导图帮助同学们快速把握本节框架和重点、通过考点分布明确高频低频核心

微信搜一搜
天天师兄

答案:9 BBC